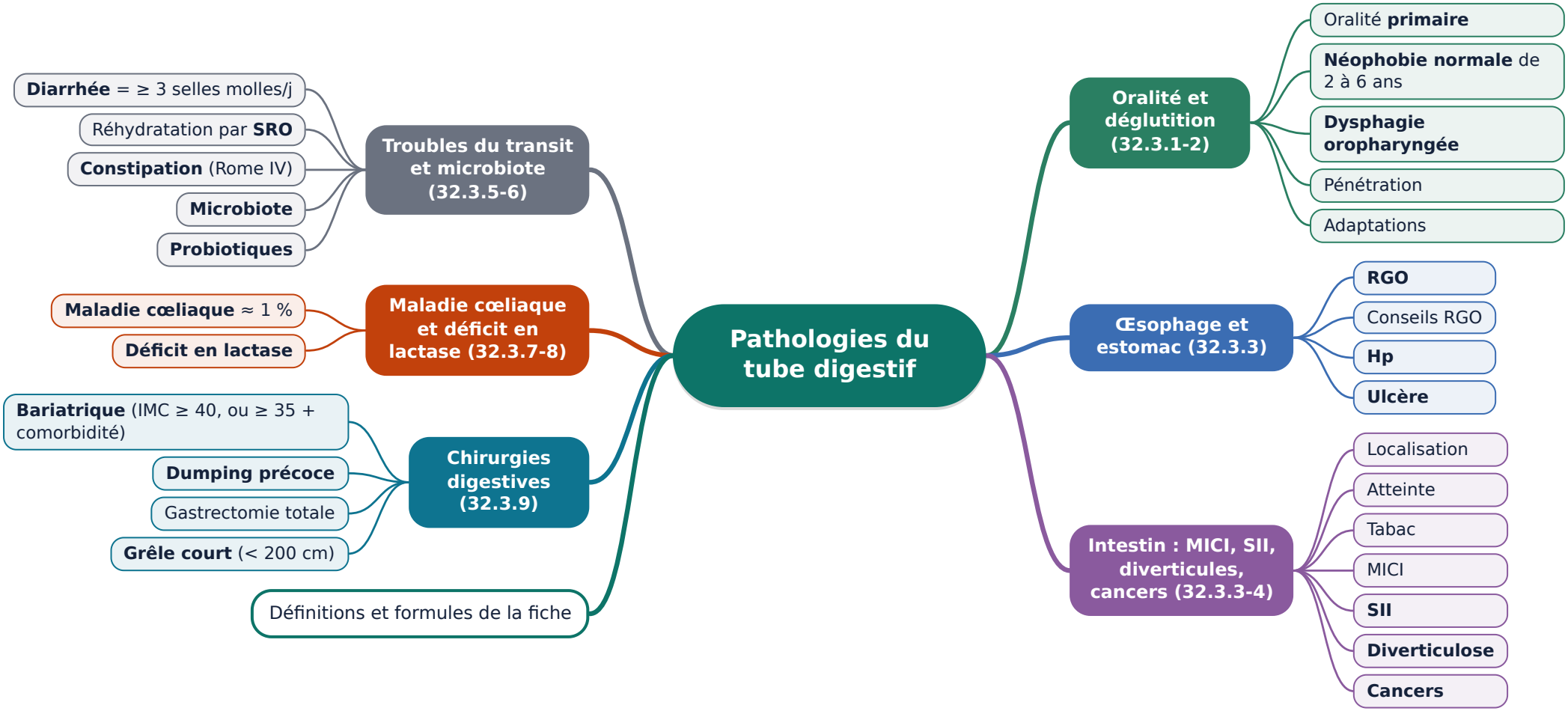
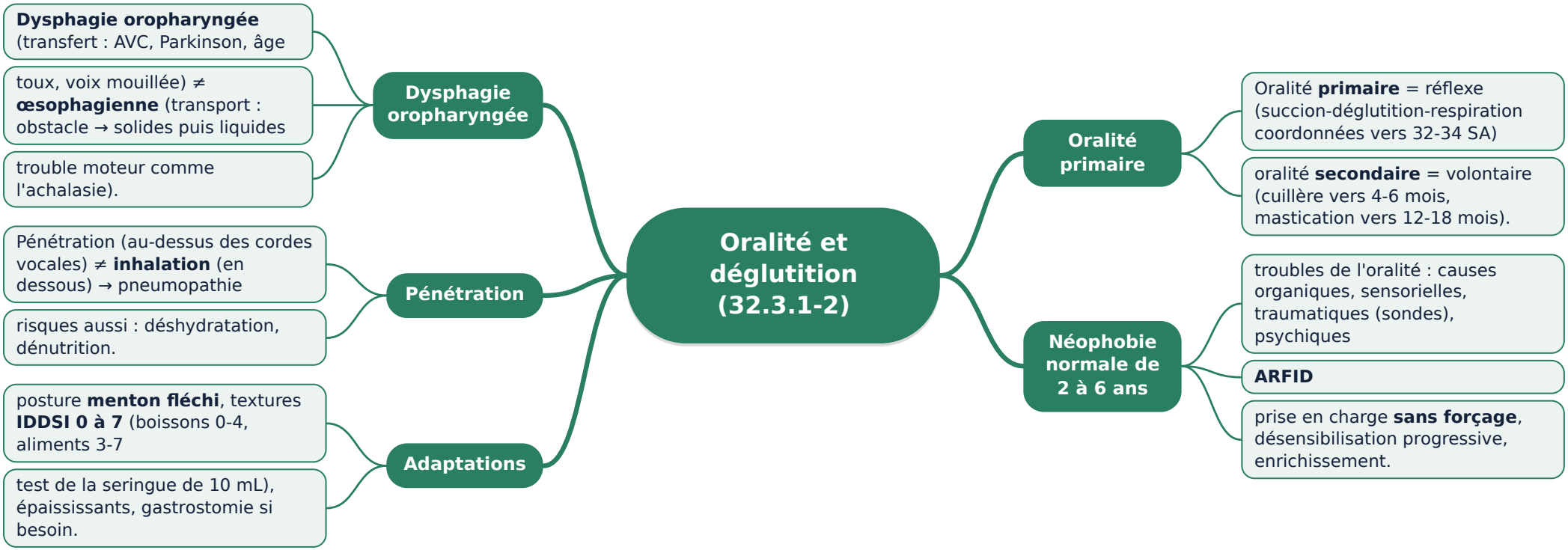
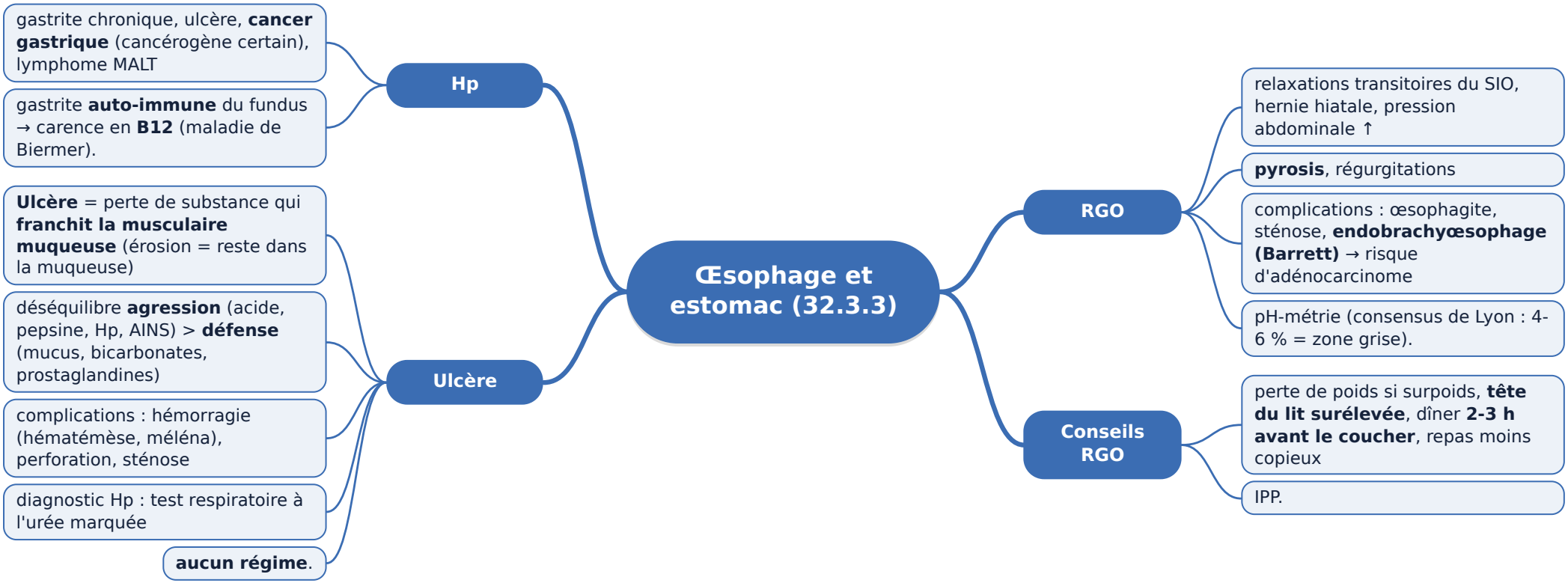
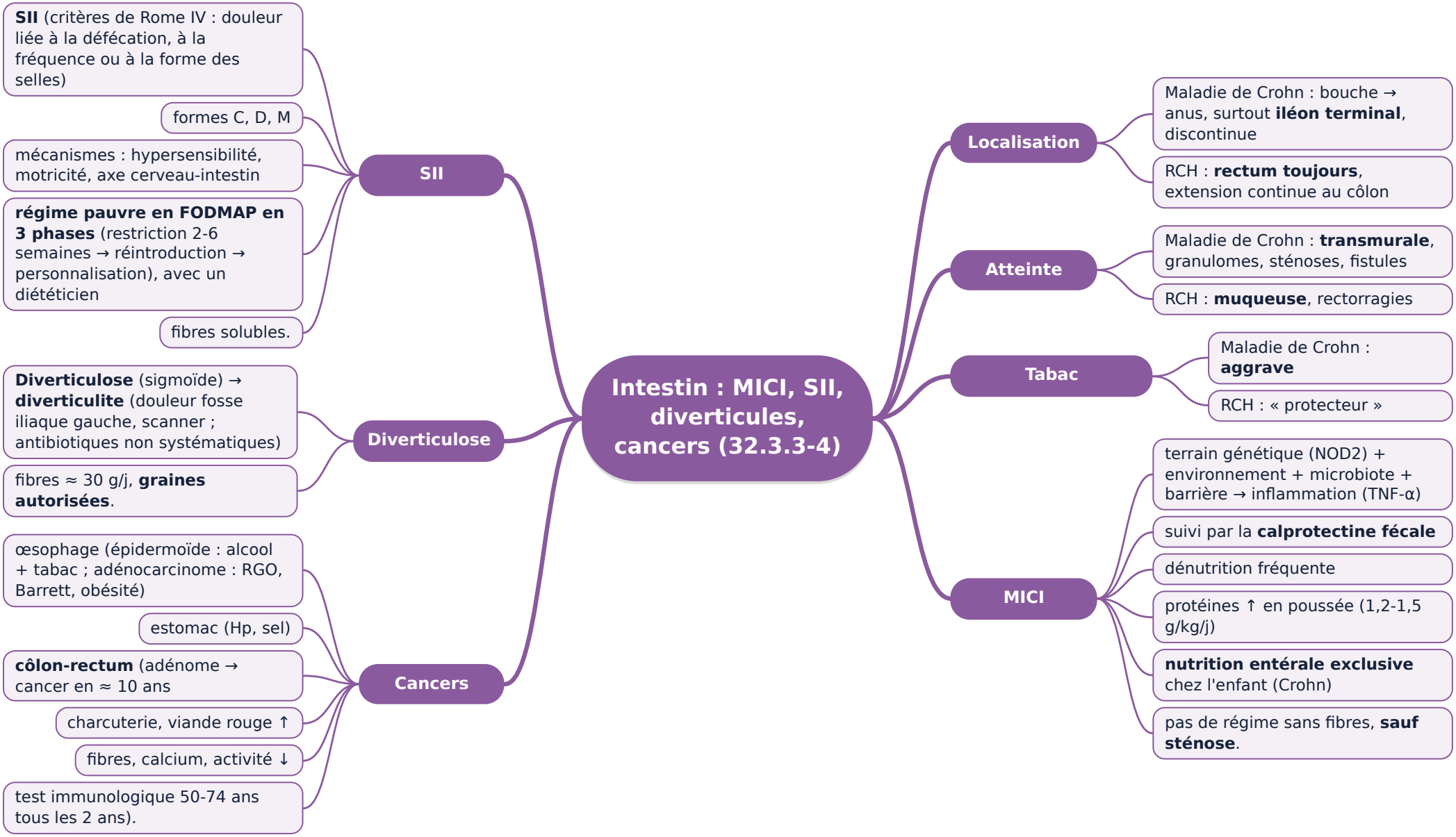
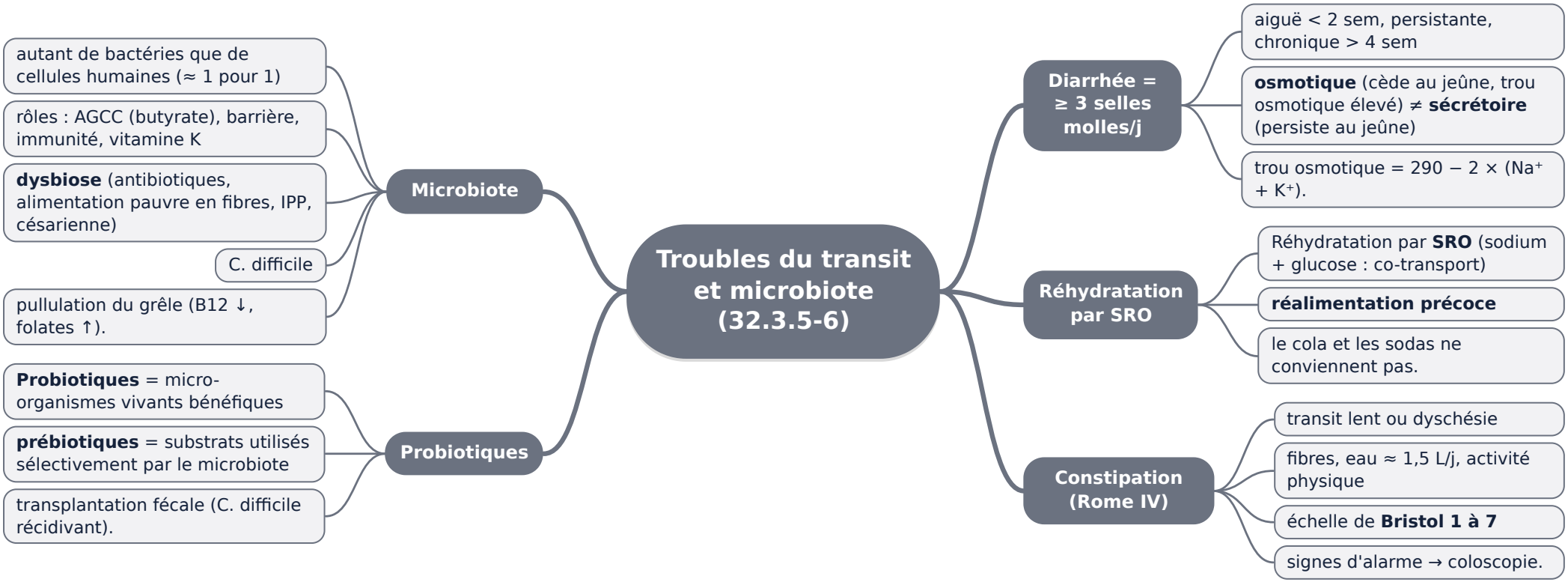

Pathologies du tube digestif
Troubles du transit et microbiote (32.3.5-6)
Diarrhée = ≥ 3 selles molles/j
Réhydratation par SRO
Constipation (Rome IV)
Microbiote
Probiotiques
Maladie cœliaque et déficit en lactase (32.3.7-8)
Maladie cœliaque ≈ 1 %
Déficit en lactase
Chirurgies digestives (32.3.9)
Bariatrique (IMC ≥ 40, ou ≥ 35 + comorbidité)
Dumping précoce
Gastrectomie totale
Grêle court (< 200 cm)
Définitions et formules de la fiche
Oralité et déglutition (32.3.1-2)
Oralité primaire
Néophobie normale de 2 à 6 ans
Dysphagie oropharyngée
Pénétration
Adaptations
Œsophage et estomac (32.3.3)
RGO
Conseils RGO
Hp
Ulcère
Intestin : MICI, SII, diverticules, cancers (32.3.3-4)
Localisation
Atteinte
Tabac
MICI
SII
Diverticulose
Cancers

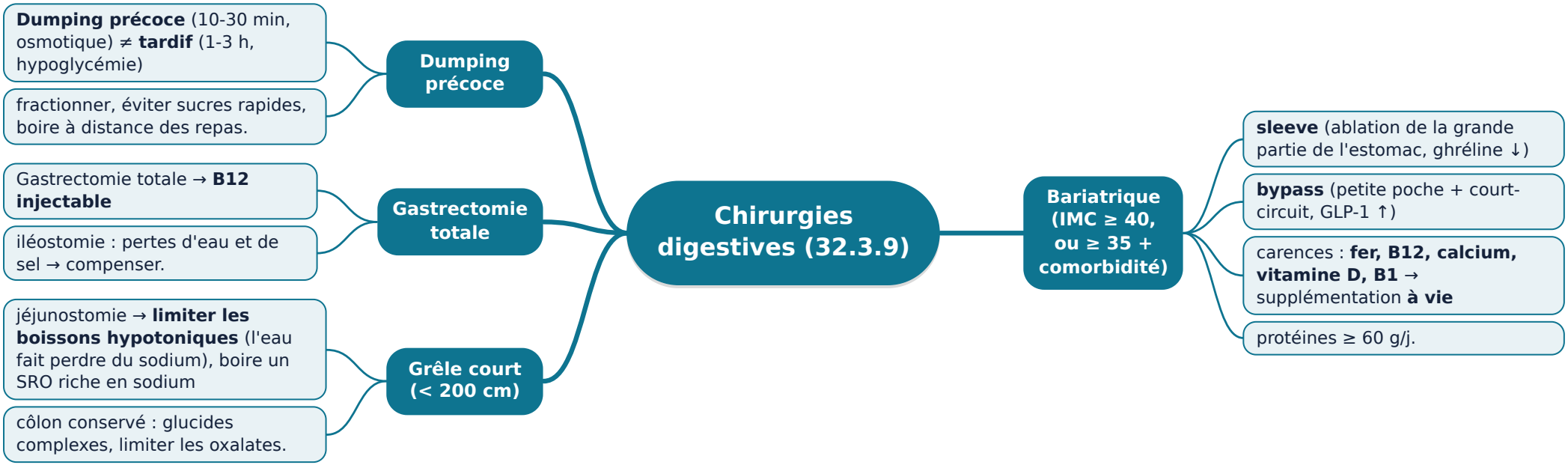

Oralité et déglutition (32.3.1-2)
Dysphagie oropharyngée
Dysphagie oropharyngée (transfert : AVC, Parkinson, âge
toux, voix mouillée) ≠ œsophagienne (transport : obstacle → solides puis liquides
trouble moteur comme l'achalasie).
Pénétration
Pénétration (au-dessus des cordes vocales) ≠ inhalation (en dessous) → pneumopathie
risques aussi : déshydratation, dénutrition.
Adaptations
posture menton fléchi, textures IDDSI 0 à 7 (boissons 0-4, aliments 3-7
test de la seringue de 10 mL), épaississants, gastrostomie si besoin.
Oralité primaire
Oralité primaire = réflexe (succion-déglutition-respiration coordonnées vers 32-34 SA)
oralité secondaire = volontaire (cuillère vers 4-6 mois, mastication vers 12-18 mois).
Néophobie normale de 2 à 6 ans
troubles de l'oralité : causes organiques, sensorielles, traumatiques (sondes), psychiques
ARFID
prise en charge sans forçage, désensibilisation progressive, enrichissement.

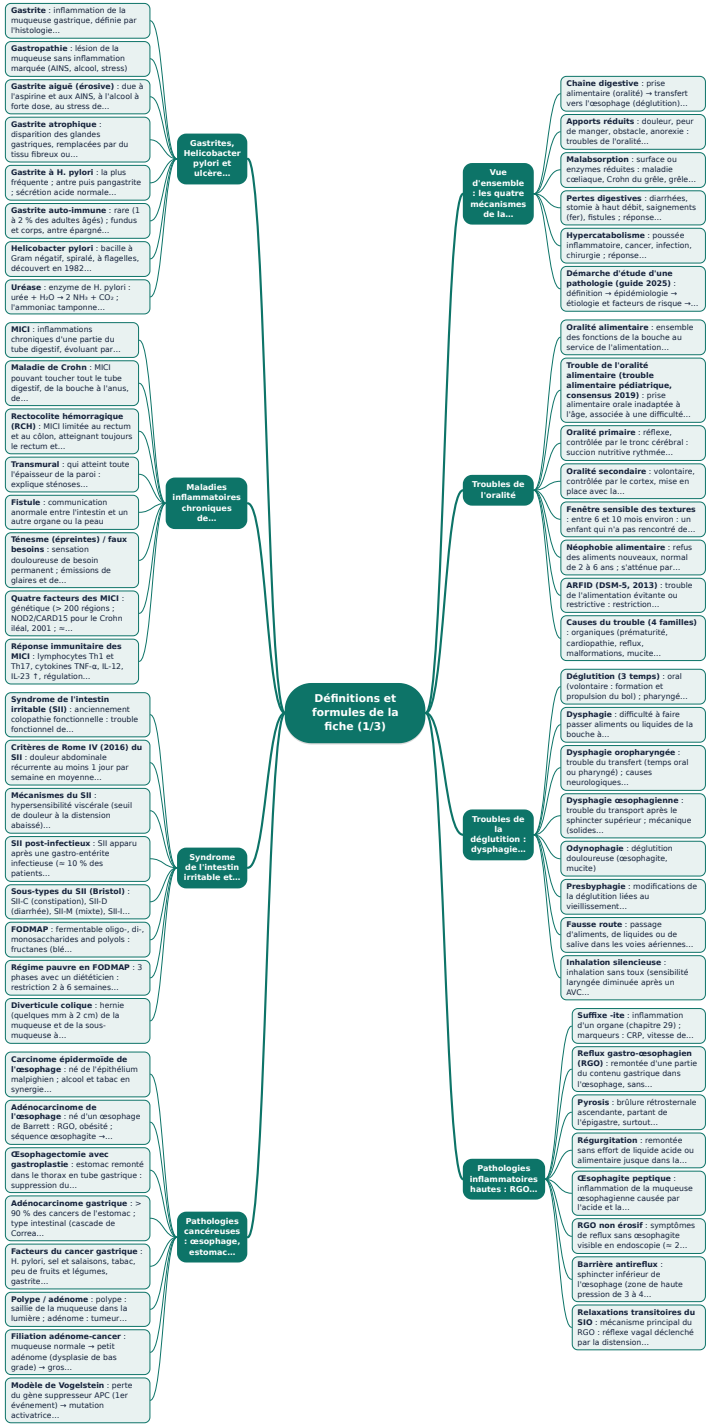

Œsophage et estomac (32.3.3)
Hp
gastrite chronique, ulcère, cancer gastrique (cancérogène certain), lymphome MALT
gastrite auto-immune du fundus → carence en B12 (maladie de Biermer).
Ulcère
Ulcère = perte de substance qui franchit la musculaire muqueuse (érosion = reste dans la muqueuse)
déséquilibre agression (acide, pepsine, Hp, AINS) > défense (mucus, bicarbonates, prostaglandines)
complications : hémorragie (hématémèse, méléna), perforation, sténose
diagnostic Hp : test respiratoire à l'urée marquée
aucun régime.
RGO
relaxations transitoires du SIO, hernie hiatale, pression abdominale ↑
pyrosis, régurgitations
complications : œsophagite, sténose, endobrachyœsophage (Barrett) → risque d'adénocarcinome
pH-métrie (consensus de Lyon : 4-6 % = zone grise).
Conseils RGO
perte de poids si surpoids, tête du lit surélevée, dîner 2-3 h avant le coucher, repas moins copieux
IPP.

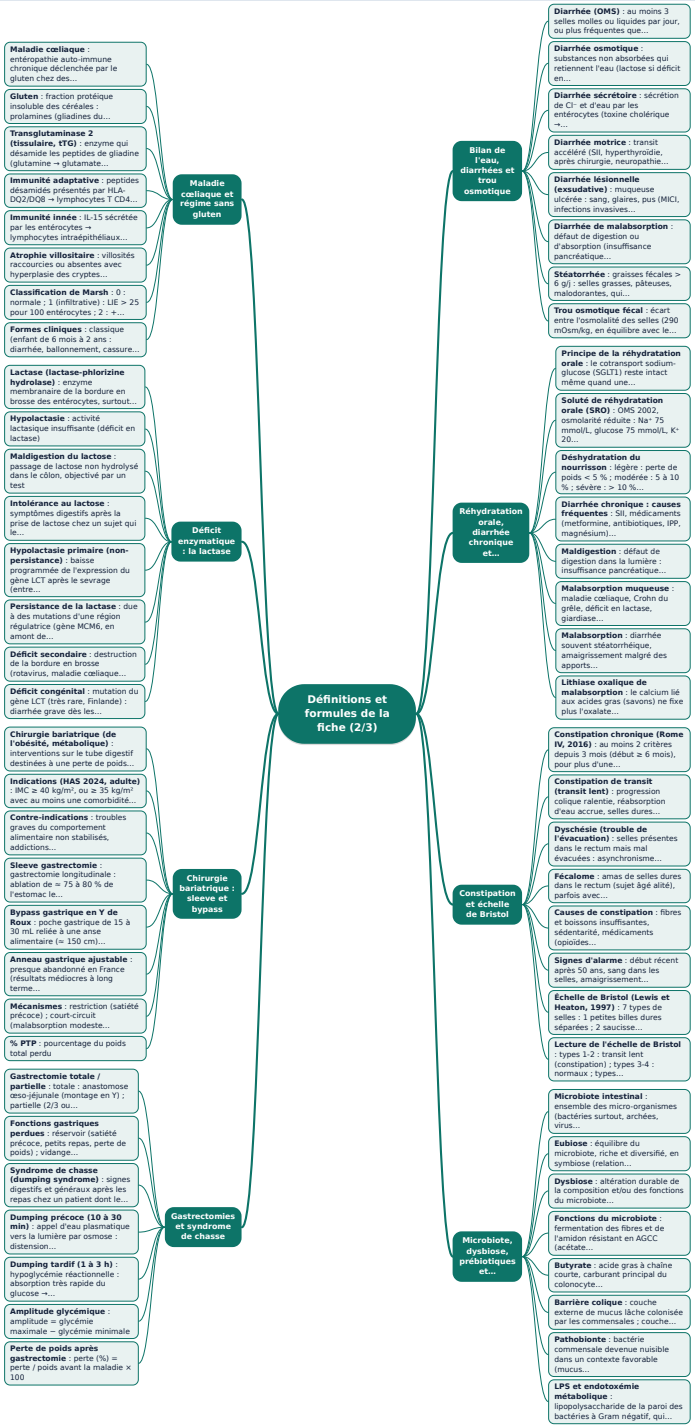

Intestin : MICI, SII, diverticules, cancers (32.3.3-4)
SII
SII (critères de Rome IV : douleur liée à la défécation, à la fréquence ou à la forme des selles)
formes C, D, M
mécanismes : hypersensibilité, motricité, axe cerveau-intestin
régime pauvre en FODMAP en 3 phases (restriction 2-6 semaines → réintroduction → personnalisation), avec un diététicien
fibres solubles.
Diverticulose
Diverticulose (sigmoïde) → **diverticulite** (douleur fosse iliaque gauche, scanner ; antibiotiques non systématiques)
fibres ≈ 30 g/j, **graines autorisées**.
Cancers
œsophage (épidermoïde : alcool + tabac ; adénocarcinome : RGO, Barrett, obésité)
estomac (Hp, sel)
côlon-rectum (adénome → cancer en ≈ 10 ans
charcuterie, viande rouge ↑
fibres, calcium, activité ↓
test immunologique 50-74 ans tous les 2 ans).
Localisation
Maladie de Crohn : bouche → anus, surtout **iléon terminal**, discontinue
RCH : **rectum toujours**, extension continue au côlon
Atteinte
Maladie de Crohn : **transmurale**, granulomes, sténoses, fistules
RCH : **muqueuse**, rectorragies
Tabac
Maladie de Crohn : **aggrave**
RCH : « protecteur »
MICI
terrain génétique (NOD2) + environnement + microbiote + barrière → inflammation (TNF-α)
suivi par la **calprotectine fécale**
dénutrition fréquente
protéines ↑ en poussée (1,2-1,5 g/kg/j)
nutrition entérale exclusive chez l'enfant (Crohn)
pas de régime sans fibres, **sauf sténose**.


Troubles du transit et microbiote (32.3.5-6)
Microbiote
autant de bactéries que de cellules humaines (≈ 1 pour 1)
rôles : AGCC (butyrate), barrière, immunité, vitamine K
dysbiose (antibiotiques, alimentation pauvre en fibres, IPP, césarienne)
C. difficile
pullulation du grêle (B12 ↓, folates ↑).
Probiotiques
Probiotiques = micro-organismes vivants bénéfiques
prébiotiques = substrats utilisés sélectivement par le microbiote
transplantation fécale (C. difficile récidivant).
Diarrhée = ≥ 3 selles molles/j
aiguë < 2 sem, persistante, chronique > 4 sem
osmotique (cède au jeûne, trou osmotique élevé) ≠ sécrétoire (persiste au jeûne)
trou osmotique = 290 − 2 × (Na+ + K+).
Réhydratation par SRO
Réhydratation par SRO (sodium + glucose : co-transport)
réalimentation précoce
le cola et les sodas ne conviennent pas.
Constipation (Rome IV)
transit lent ou dyschésie
fibres, eau ≈ 1,5 L/j, activité physique
échelle de Bristol 1 à 7
signes d'alarme → coloscopie.

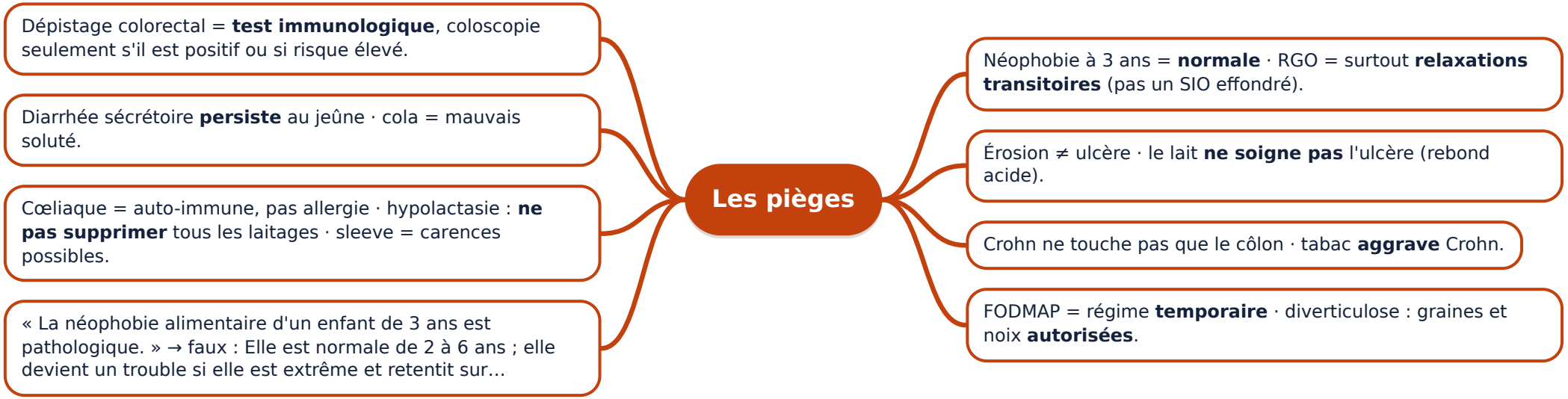

Maladie cœliaque et déficit en lactase (32.3.7-8)
Déficit en lactase
primaire (majorité de la population mondiale), secondaire (transitoire), congénital (rare)
maldigestion ≠ intolérance (symptômes : diarrhée osmotique, gaz)
test respiratoire à l'H₂
≈ 12 g de lactose par prise souvent tolérés
yaourts et fromages affinés
garder le calcium
Maladie cœliaque ≈ 1 %
Maladie cœliaque ≈ 1 % (souvent méconnue)
terrain HLA-DQ2/DQ8
gliadine modifiée par la tTG → réaction immunitaire → atrophie villositaire → carences (fer, folates, calcium)
diagnostic : IgA anti-tTG + IgA totales, biopsies
ne pas commencer le régime avant les examens
régime sans gluten strict, à vie (blé, seigle, orge)

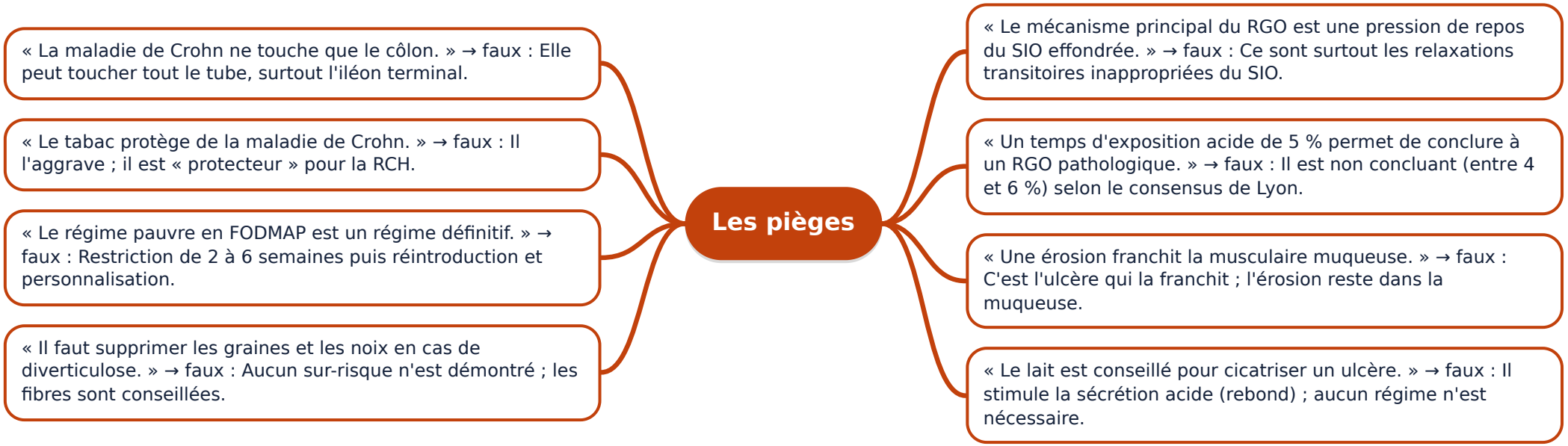

Chirurgies digestives (32.3.9)
Dumping précoce
Dumping précoce (10-30 min, osmotique) ≠ tardif (1-3 h, hypoglycémie)
fractionner, éviter sucres rapides, boire à distance des repas.
Gastrectomie totale
Gastrectomie totale → B12 injectable
iléostomie : pertes d'eau et de sel → compenser.
Grêle court (< 200 cm)
jéjunostomie → limiter les boissons hypotoniques (l'eau fait perdre du sodium), boire un SRO riche en sodium
côlon conservé : glucides complexes, limiter les oxalates.
Bariatrique (IMC ≥ 40, ou ≥ 35 + comorbidité)
sleeve (ablation de la grande partie de l'estomac, ghréline ↓)
bypass (petite poche + court-circuit, GLP-1 ↑)
carences : fer, B12, calcium, vitamine D, B1 → supplémentation à vie
protéines ≥ 60 g/j.


Définitions et formules de la fiche (1/3)
Gastrites, Helicobacter pylori et ulcère...
Gastrite : inflammation de la muqueuse gastrique, définie par l'histologie...
Gastropathie : lésion de la muqueuse sans inflammation marquée (AINS, alcool, stress)
Gastrite aiguë (érosive) : due à l'aspirine et aux AINS, à l'alcool à forte dose, au stress de...
Gastrite atrophique : disparition des glandes gastriques, remplacées par du tissu fibreux ou...
Gastrite à H. pylori : la plus fréquente ; antre puis pangastrite ; sécrétion acide normale...
Gastrite auto-immune : rare (1 à 2 % des adultes âgés) ; fundus et corps, antre épargné...
Helicobacter pylori : bacille à Gram négatif, spiralé, à flagelles, découvert en 1982...
Uréase : enzyme de H. pylori : urée + H₂O → 2 NH₃ + CO₂ ; l'ammoniac tamponne...
Maladies inflammatoires chroniques de...
MICI : inflammations chroniques d'une partie du tube digestif, évoluant par...
Maladie de Crohn : MICI pouvant toucher tout le tube digestif, de la bouche à l'anus, de...
Rectocolite hémorragique (RCH) : MICI limitée au rectum et au côlon, atteignant toujours le rectum et...
Transmural : qui atteint toute l'épaisseur de la paroi : explique sténoses...
Fistule : communication anormale entre l'intestin et un autre organe ou la peau
Ténesme (épreintes) / faux besoins : sensation douloureuse de besoin permanent ; émissions de glaires et de...
Quatre facteurs des MICI : génétique (> 200 régions ; NOD2/CARD15 pour le Crohn iléal, 2001 ; ≈...
Réponse immunitaire des MICI : lymphocytes Th1 et Th17, cytokines TNF-α, IL-12, IL-23 ↑, régulation...
Syndrome de l'intestin irritable et...
Syndrome de l'intestin irritable (SII) : anciennement colopathie fonctionnelle : trouble fonctionnel de...
Critères de Rome IV (2016) du SII : douleur abdominale récurrente au moins 1 jour par semaine en moyenne...
Mécanismes du SII : hypersensibilité viscérale (seuil de douleur à la distension abaissé)...
SII post-infectieux : SII apparu après une gastro-entérite infectieuse (≈ 10 % des patients...
Sous-types du SII (Bristol) : SII-C (constipation), SII-D (diarrhée), SII-M (mixte), SII-I...
FODMAP : fermentable oligo-, di-monosaccharides and polyols : fructanes (blé...
Régime pauvre en FODMAP : 3 phases avec un diététicien : restriction 2 à 6 semaines...
Diverticule colique : hernie (quelques mm à 2 cm) de la muqueuse et de la sous-muqueuse à...
Pathologies cancéreuses : œsophage, estomac...
Carcinome épidermoïde de l'œsophage : né de l'épithélium malpighien ; alcool et tabac en synergie...
Adénocarcinome de l'œsophage : né d'un œsophage de Barrett : RGO, obésité ; séquence œsophagite →...
Œsophagectomie avec gastroplastie : estomac remonté dans le thorax en tube gastrique : suppression du...
Adénocarcinome gastrique : > 90 % des cancers de l'estomac ; type intestinal (cascade de Correa...
Facteurs du cancer gastrique : H. pylori, sel et salaisons, tabac, peu de fruits et légumes, gastrite...
Polype / adénome : polype : saillie de la muqueuse dans la lumière ; adénome : tumeur...
Filiation adénome-cancer : muqueuse normale → petit adénome (dysplasie de bas grade) → gros...
Modèle de Vogelstein : perte du gène suppresseur APC (1er événement) → mutation activatrice...
Vue d'ensemble : les quatre mécanismes de la...
Chaîne digestive : prise alimentaire (oralité) → transfert vers l'œsophage (déglutition)...
Apports réduits : douleur, peur de manger, obstacle, anorexie : troubles de l'oralité...
Malabsorption : surface ou enzymes réduites : maladie cœliaque, Crohn du grêle, grêle...
Pertes digestives : diarrhées, stomie à haut débit, saignements (fer), fistules : réponse...
Hypercatabolisme : poussée inflammatoire, cancer, infection, chirurgie ; réponse...
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025) : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque →...
Troubles de l'oralité
Oralité alimentaire : ensemble des fonctions de la bouche au service de l'alimentation...
Trouble de l'oralité alimentaire (trouble alimentaire pédiatrique, consensus 2019) : prise alimentaire orale inadaptée à l'âge, associée à une difficulté...
Oralité primaire : réflexe, contrôlée par le tronc cérébral : succion nutritive rythmée...
Oralité secondaire : volontaire, contrôlée par le cortex, mise en place avec la...
Fenêtre sensible des textures : entre 6 et 10 mois environ : un enfant qui n'a pas rencontré de...
Néophobie alimentaire : refus des aliments nouveaux, normal de 2 à 6 ans ; s'atténue par...
ARFID (DSM-5, 2013) : trouble de l'alimentation évitante ou restrictive : restriction...
Causes du trouble (4 familles) : organiques (prématurité, cardiopathie, reflux, malformations, mucite...
Troubles de la déglutition : dysphagie...
Déglutition (3 temps) : oral (volontaire : formation et propulsion du bol) ; pharyngé...
Dysphagie : difficulté à faire passer aliments ou liquides de la bouche à...
Dysphagie oropharyngée : trouble du transfert (temps oral ou pharyngé) ; causes neurologiques...
Dysphagie œsophagienne : trouble du transport après le sphincter supérieur ; mécanique (solides...
Odynophagie : déglutition douloureuse (œsophagite, mucite)
Presbyphagie : modifications de la déglutition liées au vieillissement...
Fausse route : passage d'aliments, de liquides ou de salive dans les voies aériennes...
Inhalation silencieuse : inhalation sans toux (sensibilité laryngée diminuée après un AVC...
Pathologies inflammatoires hautes : RGO...
Suffixe -ite : inflammation d'un organe (chapitre 29) ; marqueurs : CRP, vitesse de...
Reflux gastro-œsophagien (RGO) : remontée d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage, sans...
Pyrosis : brûlure rétrosternale ascendante, partant de l'épigastre, surtout...
Régurgitation : remontée sans effort de liquide acide ou alimentaire jusque dans la...
Œsophagite peptique : inflammation de la muqueuse œsophagienne causée par l'acide et la...
RGO non érosif : symptômes de reflux sans œsophagite visible en endoscopie (≈ 2...
Barrière antireflux : sphincter inférieur de l'œsophage (zone de haute pression de 3 à 4...
Relaxations transitoires du SIO : mécanisme principal du RGO : réflexe vagal déclenché par la distension...


Définitions et formules de la fiche (2/3)
Maladie cœliaque et régime sans gluten
Maladie cœliaque : entéropathie auto-immune chronique déclenchée par le gluten chez des...
Gluten : fraction protéique insoluble des céréales : prolamines (gliadines du...
Transglutaminase 2 (tissulaire, tTG) : enzyme qui désamide les peptides de gliadine (glutamine → glutamate...
Immunité adaptative : peptides désamidés présentés par HLA-DQ2/DQ8 → lymphocytes T CD4...
Immunité innée : IL-15 sécrétée par les entérocytes → lymphocytes intraépithéliaux...
Atrophie villositaire : villosités raccourcies ou absentes avec hyperplasie des cryptes...
Classification de Marsh : 0 : normale ; 1 (infiltrative) : LIE > 25 pour 100 entérocytes ; 2 : +...
Formes cliniques : classique (enfant de 6 mois à 2 ans : diarrhée, ballonnement, cassure...
Déficit enzymatique : la lactase
Lactase (lactase-phlorizine hydrolase) : enzyme membranaire de la bordure en brosse des entérocytes, surtout...
Hypolactasie : activité lactasique insuffisante (déficit en lactase)
Maldigestion du lactose : passage de lactose non hydrolysé dans le côlon, objectivé par un test
Intolérance au lactose : symptômes digestifs après la prise de lactose chez un sujet qui le...
Hypolactasie primaire (non-persistance) : baisse programmée de l'expression du gène LCT après le sevrage (entre...
Persistance de la lactase : due à des mutations d'une région régulatrice (gène MCM6, en amont de...
Déficit secondaire : destruction de la bordure en brosse (rotavirus, maladie cœliaque...
Déficit congénital : mutation du gène LCT (très rare, Finlande) : diarrhée grave dès les...
Chirurgie bariatrique : sleeve et bypass
Chirurgie bariatrique (de l'obésité, métabolique) : interventions sur le tube digestif destinées à une perte de poids...
Indications (HAS 2024, adulte) : IMC ≥ 40 kg/m², ou ≥ 35 kg/m² avec au moins une comorbidité...
Contre-indications : troubles graves du comportement alimentaire non stabilisés, addictions...
Sleeve gastrectomie : gastrectomie longitudinale : ablation de ≈ 75 à 80 % de l'estomac le...
Bypass gastrique en Y de Roux : poche gastrique de 15 à 30 mL reliée à une anse alimentaire (≈ 150 cm)...
Anneau gastrique ajustable : presque abandonné en France (résultats médiocres à long terme...
Mécanismes : restriction (satiété précoce) ; court-circuit (malabsorption modeste...
% PTP : pourcentage du poids total perdu
Gastrectomies et syndrome de chasse
Gastrectomie totale / partielle : totale : anastomose œso-jéjunale (montage en Y) ; partielle (2/3 ou...
Fonctions gastriques perdues : réservoir (satiété précoce, petits repas, perte de poids) ; vidange...
Syndrome de chasse (dumping syndrome) : signes digestifs et généraux après les repas chez un patient dont le...
Dumping précoce (10 à 30 min) : appel d'eau plasmatique vers la lumière par osmose : distension...
Dumping tardif (1 à 3 h) : hypoglycémie réactionnelle : absorption très rapide du glucose →...
Amplitude glycémique : amplitude = glycémie maximale − glycémie minimale
Perte de poids après gastrectomie : perte (%) = perte / poids avant la maladie × 100
Bilan de l'eau, diarrhées et trou osmotique
Diarrhée (OMS) : au moins 3 selles molles ou liquides par jour, ou plus fréquentes que...
Diarrhée osmotique : substances non absorbées qui retiennent l'eau (lactose si déficit en...
Diarrhée sécrétoire : sécrétion de Cl⁻ et d'eau par les entérocytes (toxine cholérique →...
Diarrhée motrice : transit accéléré (SII, hyperthyroïdie, après chirurgie, neuropathie...
Diarrhée lésionnelle (exsudative) : muqueuse ulcérée : sang, glaires, pus (MICI, infections invasives...
Diarrhée de malabsorption : défaut de digestion ou d'absorption (insuffisance pancréatique...
Stéatorrhée : graisses fécales > 6 g/j : selles grasses, pâteuses, malodorantes, qui...
Trou osmotique fécal : écart entre l'osmolalité des selles (290 mOsm/kg, en équilibre avec le...
Réhydratation orale, diarrhée chronique et...
Principe de la réhydratation orale : le cotransport sodium-glucose (SGLT1) reste intact même quand une...
Soluté de réhydratation orale (SRO) : OMS 2002, osmolarité réduite : Na⁺ 75 mmol/L, glucose 75 mmol/L, K⁺ 20...
Déshydratation du nourrisson : légère : perte de poids < 5 % ; modérée : 5 à 10 % ; sévère : > 10 %...
Diarrhée chronique : causes fréquentes : SII, médicaments (metformine, antibiotiques, IPP, magnésium)...
Maldigestion : défaut de digestion dans la lumière : insuffisance pancréatique...
Malabsorption muqueuse : maladie cœliaque, Crohn du grêle, déficit en lactase, giardiase...
Malabsorption : diarrhée souvent stéatorrhéique, amaigrissement malgré des apports...
Lithiase oxalique de malabsorption : le calcium lié aux acides gras (savons) ne fixe plus l'oxalate...
Constipation et échelle de Bristol
Constipation chronique (Rome IV, 2016) : au moins 2 critères depuis 3 mois (début ≥ 6 mois), pour plus d'une...
Constipation de transit (transit lent) : progression colique ralentie, réabsorption d'eau accrue, selles dures...
Dyschésie (trouble de l'évacuation) : selles présentes dans le rectum mais mal évacuées : asynchronisme...
Fécalome : amas de selles dures dans le rectum (sujet âgé alité), parfois avec...
Causes de constipation : fibres et boissons insuffisantes, sédentarité, médicaments (opioïdes...
Signes d'alarme : début récent après 50 ans, sang dans les selles, amaigrissement...
Échelle de Bristol (Lewis et Heaton, 1997) : 7 types de selles : 1 petites billes dures séparées ; 2 saucisse...
Lecture de l'échelle de Bristol : types 1-2 : transit lent (constipation) ; types 3-4 : normaux ; types...
Microbiote, dysbiose, prébiotiques et...
Microbiote intestinal : ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, virus...
Eubiose : équilibre du microbiote, riche et diversifié, en symbiose (relation...
Dysbiose : altération durable de la composition et/ou des fonctions du microbiote...
Fonctions du microbiote : fermentation des fibres et de l'amidon résistant en AGCC (acétate...
Butyrate : acide gras à chaîne courte, carburant principal du colonocyte...
Barrière colique : couche externe de mucus lâche colonisée par les commensales ; couche...
Pathobionte : bactérie commensale devenue nuisible dans un contexte favorable (mucus...
LPS et endotoxémie métabolique : lipopolysaccharide de la paroi des bactéries à Gram négatif, qui...


Définitions et formules de la fiche (3/3)
Applications : nutrition artificielle…
Progression de la stratégie nutritionnelle (HAS 2019 et 2021, SFNCM, ESPEN) : alimentation orale adaptée et enrichie → compléments nutritionnels…
Sonde nasogastrique : nutrition entérale de courte durée (moins de 4 à 6 semaines) : AVC…
Gastrostomie (ou jéjunostomie) d'alimentation : sonde à travers la paroi abdominale (gastrostomie percutanée…
Nutrition parentérale : par veine centrale (cathéter, chambre implantable) ; complications…
Mélanges de nutrition entérale : polymériques (protéines entières, triglycérides, glucides complexes…
Textures en restauration collective : cadre IDDSI partagé (fiche par résident, tests en cuisine), hygiène du…
Régime pauvre en FODMAP (Monash) : 2e intention dans le SII après les conseils de base (NICE 2017, SNFGE)…
Contre-indications du régime FODMAP : dénutrition, trouble du comportement alimentaire, anxiété alimentaire…
Unités, conversions et signes digestifs
Épigastralgie : douleur du creux de l'estomac : ulcère, gastrite, dyspepsie, cancer…
Syndrome dysentérique : selles glairo-sanglantes, fièvre, ténesme : diarrhée invasive, MICI
Méthode d'utilisation d'une formule : écrire la formule, remplacer par les valeurs avec les unités, donner…
Critères de dénutrition (HAS 2019 adulte, 2021 ≥ 70 ans) : au moins un critère phénotypique (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6…
Dénutrition sévère (≥ 70 ans, HAS 2021) : IMC < 20 kg/m², perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou…
Glycémie : mmol/L = g/L × 5,55
Hémoglobine : g/L = g/dL × 10
Vitesse de croissance : vitesse (cm/an) = taille finale − taille initiale (sur 1 an)
Colectomies, stomies et grêle court
Colectomie / proctectomie / coloproctectomie : ablation de tout ou partie du côlon (hémicolectomie droite ou gauche…
Stomie digestive : abouchement d'un segment du tube digestif à la peau de l'abdomen…
Iléostomie : après colectomie totale, en fosse iliaque droite : selles liquides…
Colostomie gauche (Hartmann) : après résection du sigmoïde, en fosse iliaque gauche, moignon rectal…
Anastomose iléo-anale avec réservoir en J : après coloproctectomie (RCH réfractaire, polypose) : pas de stomie…
Syndrome du grêle court : conséquences d'une résection laissant moins de 200 cm de grêle…
Insuffisance intestinale (ESPEN 2015) : réduction de la fonction intestinale en dessous du minimum nécessaire…
Classification de Messing : type 1 : jéjunostomie terminale ; type 2 : anastomose jéjuno-colique…


Les pièges
Dépistage colorectal = **test immunologique**, coloscopie seulement s'il est positif ou si risque élevé.
Diarrhée sécrétoire **persiste** au jeûne · cola = mauvais soluté.
Cœliaque = auto-immune, pas allergie · hypolactasie : **ne pas supprimer** tous les laitages · sleeve = carences possibles.
« La néophobie alimentaire d'un enfant de 3 ans est pathologique. » → faux : Elle est normale de 2 à 6 ans ; elle devient un trouble si elle est extrême et retentit sur…
Néophobie à 3 ans = **normale** · RGO = surtout **relaxations transitoires** (pas un SIO effondré).
Érosion ≠ ulcère · le lait **ne soigne pas** l'ulcère (rebond acide).
Crohn ne touche pas que le côlon · tabac **aggrave** Crohn.
FODMAP = régime **temporaire** · diverticulose : graines et noix **autorisées**.


Les pièges
« La maladie de Crohn ne touche que le côlon. » → faux : Elle peut toucher tout le tube, surtout l'iléon terminal.
« Le tabac protège de la maladie de Crohn. » → faux : Il l'aggrave ; il est « protecteur » pour la RCH.
« Le régime pauvre en FODMAP est un régime définitif. » → faux : Restriction de 2 à 6 semaines puis réintroduction et personnalisation.
« Il faut supprimer les graines et les noix en cas de diverticulose. » → faux : Aucun sur-risque n'est démontré ; les fibres sont conseillées.
« Le mécanisme principal du RGO est une pression de repos du SIO effondrée. » → faux : Ce sont surtout les relaxations transitoires inappropriées du SIO.
« Un temps d'exposition acide de 5 % permet de conclure à un RGO pathologique. » → faux : Il est non concluant (entre 4 et 6 %) selon le consensus de Lyon.
« Une érosion franchit la musculaire muqueuse. » → faux : C'est l'ulcère qui la franchit ; l'érosion reste dans la muqueuse.
« Le lait est conseillé pour cicatriser un ulcère. » → faux : Il stimule la sécrétion acide (rebond) ; aucun régime n'est nécessaire.